E-Book

Pflegetechniken von A bis Z

Kirschnick O • Thieme 2024

Videos anzeigen

P > Pneumonieprophylaxe, Atelektasenprophylaxe

Olaf Kirschnick

Pneumonieprophylaxe, Atelektasenprophylaxe

Definitionen

Pneumonieprophylaxe

Vorbeugende Maßnahmen, um das Entstehen einer Lungenentzündung zu vermeiden. Dazu zählen u.a. die

Beobachtung von Auswurf, die Verbesserung der Lungenventilation z.B. durch häufiges Umlagern bzw. spezielle Lagerungstechniken oder eine atemstimulierende Einreibung, die Sekretmobilisation, z.B. durch Atemtraining, und die Förderung der Sekretentleerung, z.B. durch ➞*Abhusten* , ➞*Abklopfen* und ➞*Vibrieren* . Mehr finden Sie in den Kapiteln „Absaugen“ und „Inhalationen“.

Atelektasen

Atelektasen sind luftleere Lungenbezirke, die nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen. Sie können z.B. angeboren sein bei Säuglingen oder z.B. durch Operationen, Bettlägerigkeit oder Schonatmung entstehen.

Atelektasenprophylaxe

Maßnahmen, um die Bildung von Atelektasen zu verhindern, z.B. durch Atemtherapie.

Atemstimulierende Einreibung (ASE)

Eine in der Hand angewärmte Lotion oder Salbe wird mit kreisenden Bewegungen in einem bestimmten Rhythmus auf den Rücken aufgetragen. Dies führt zu einer vertieften Atmung und damit zu einer verringerten Pneumoniegefahr. Außerdem wirkt sie beruhigend und führt zu einer verstärkten Körperwahrnehmung bei bewusstseinsgestörten oder verwirrten Patienten.

Atemtraining

Verfahren zum Training der Lungenfunktion durch Beeinflussung der Einatmung z.B. durch **S**ustained-**M**aximal-**I**nspiration-Trainer (lange anhaltende Einatmung, SMI-Trainer) oder der Ausatmung z.B. durch **V**ario-

Resistance-**P**ressure-Gerät (VRP) oder **P**ositive **E**xpiratory **P**ressure (PEP).

Atemstimulierende Einreibungen (ASE)

Ziele und Indikationen

Ziele und Indikationen einer atemstimulierenden Einreibung sind die Vertiefung der Atmung, die Beruhigung und Entspannung und die Förderung der Körperwahrnehmung bei z.B. Patienten mit Atemstörungen (➞*Ateminsuffizienz*), Schonatmung durch Schmerzen und vor und nach operativen Eingriffen z.B. ➞*Strumaresektion* .

Vorbereitung der Materialien

- ➞*Patientendokumentation* mit ärztlicher Verordnung
- alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel
- unparfümierte Wasser-in-Öl-Lotion oder Massageöl

Durchführung

- ➞*Patientendokumentation* mit ärztlicher Verordnung prüfen und Hände nach ➞*Hygieneplan* desinfizieren.
- Patienten über geplante Maßnahme informieren (auch bewusstlose Patienten!) und Zeitpunkt der Durchführung, wenn möglich, mit ihm abstimmen. Anwesenheitslicht einschalten, Fenster und Türen schließen und auf angenehme Raumtemperatur achten.
- Wenn möglich, Mitpatienten und Besucher bitten,

das Zimmer zu verlassen oder für Sichtschutz sorgen.

- Unparfümierte Wasser-in-Öl-Lotion oder Massageöl auf eine wischdesinfizierte Arbeitsfläche (z.B. Tablett) richten.
- ➞*Patientenbett* auf eine rückenschonende Arbeitshöhe (Beckenhöhe) bringen und evtl. den Handlungsablauf störende Kleidungsstücke entfernen, dabei die Intimsphäre beachten, für ausreichenden Wärmeschutz sorgen.
- Patienten unterstützen, sitzende Haltung einzunehmen und Arme aufzustützen (an der Bettkante: Patient stützt sich auf Nachttisch; im Bett: Patient stützt sich auf voluminöses Kissen; immobile Patienten in 135°-Lagerung bringen).
- Einen Spritzer der Lotion zwischen den Händen anwärmen, dabei keine Handschuhe oder Ringe bzw. Armbanduhr tragen.
- Lotion in langen, gleichmäßigen Strichen von oben nach unten auf dem Rücken des Patienten verteilen; Patienten bitten, nicht zu reden (Pflegefachkraft sollte auch nicht sprechen!), sich zu entspannen und sich auf die Berührung zu konzentrieren.
- Hände auf der Schulter des Patienten ablegen: Finger und Daumen liegen aneinander, die gesamte Handfläche ruht auf der Haut des Patienten.
- Hände gleiten in Kreisbewegungen nach unten, dabei üben Daumen und Zeigefinger einen sanften Druck aus.

- Während der Ausatmung beidseits der Wirbelsäule leichten Druck ausüben und die Kreisbewegung nach außen beginnen (Abb. 60.1).
- Den Druck langsam reduzieren, sodass während der ➞*Inspiration* der Kreis in Richtung Wirbelsäule ohne Druck geschlossen wird.
- In dieser Weise mehrere Kreisbewegungen bis zum unteren Rand des Brustkorbes ausführen,
- anschließend die Hände nacheinander lösen und auf die Schultern zur Ausgangsposition zurücklegen.
- 5–8-mal in gleichmäßigem ➞*Atemrhythmus* den gesamten Rücken einreiben; abschließend vom Nacken bis zum Steißbein ausstreichen.
- Rücken warm zudecken und Patienten ruhen lassen.
- Patienten evtl. beim Rücklagern bzw. Anziehen unterstützen und ➞*Patientenbett* wieder auf eine für ihn sichere Höhe bringen (➞*Sturzprophylaxe*).

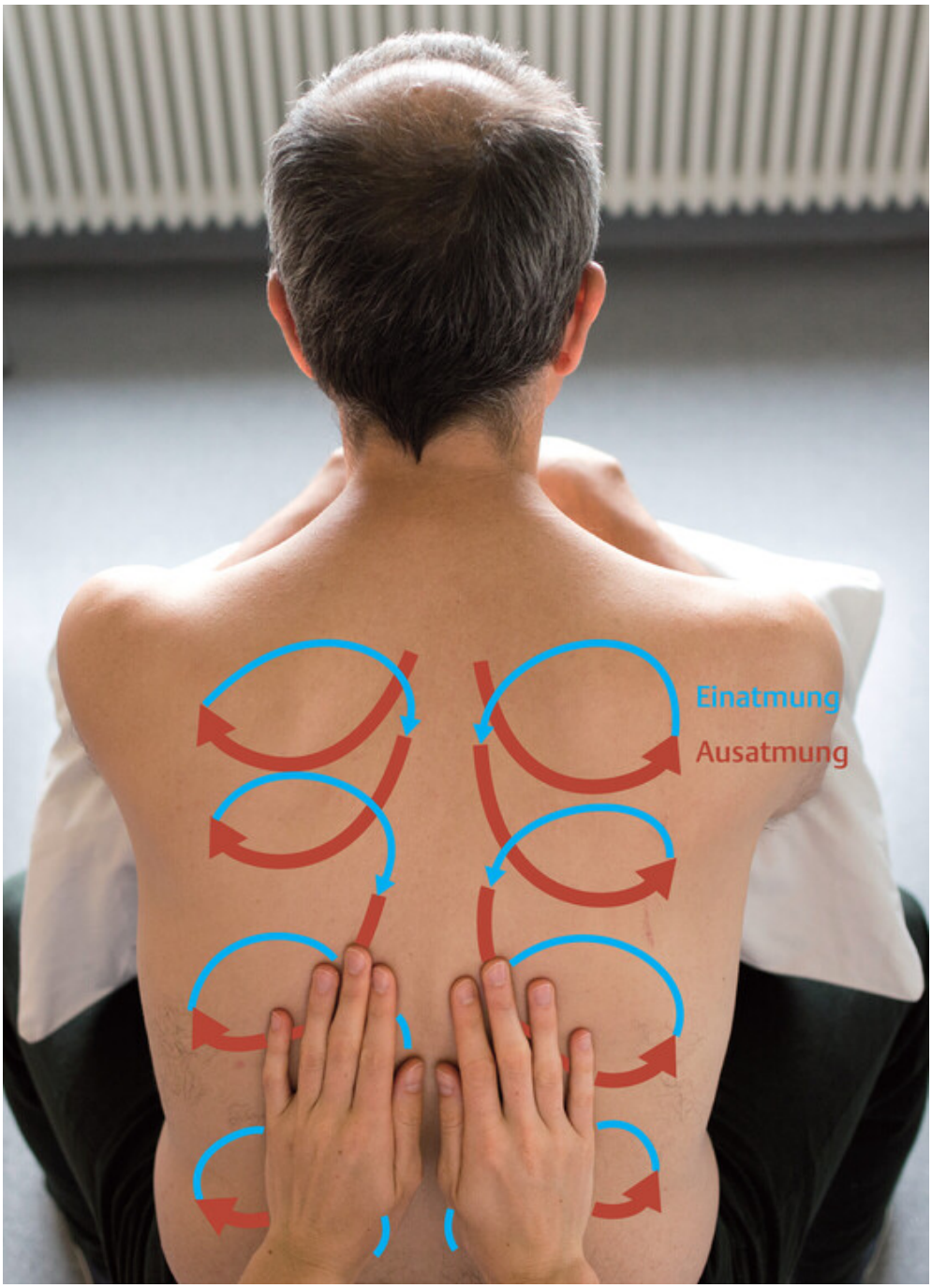


Abb. 60.1 Atemstimulierende Einreibungen.

(Quelle: © A. Fischer/Thieme)

Merke

Während der gesamten Einreibung bleibt der Körperkontakt zwischen der Pflegekraft und dem Patienten bestehen. Zum Zurückbringen der Hände vom Steiß- zum Nackenbereich die Hände versetzt vom Rücken nehmen.

Nachbereitung

- Überprüfen, ob Rufanlage bzw. Multimedia-Terminal mit z.B. Telefon, Fernseher und Internet in Reichweite sind.
- Vor dem Verlassen des Zimmers den Patienten nach dem Befinden und seinen Bedürfnissen bezüglich Lagerung, Getränken, Belüftung des Zimmers usw. fragen.
- Gebrauchte Materialien sachgerecht ver- bzw. entsorgen (z.B. Arbeitsfläche desinfizieren).
- Abschließend Hände nach ➞*Hygieneplan* desinfizieren.
- Maßnahme durch Eintragung in die ➞*Patientendokumentation* mit Handzeichen und Uhrzeit dokumentieren.

Blick zurück

Hat der Patient Ruhe? Ist er gut zugedeckt? Sind alle benutzen Gegenstände aus dem Bett entfernt worden?

Atemtraining

Ziele und Indikationen

Ziele und Indikationen eines Atemtrainings sind die Verbesserung der Atemfunktion durch Training der Ein- und Ausatmung bei Patienten mit schlechter oder ungenügender Belüftung der Lunge durch flachere Atmung, z.B. nach Operationen und bei Bettlägerigkeit.

> **Merke**
>
> Patienten mit geplanten Eingriffen sollten bereits vor der Operation von der Physiotherapie in Techniken zum schmerzfreien Atmen und Abhusten sowie in die Anwendung des Atemtrainers eingewiesen werden.

Vorbereitung der Materialien

- ➝*Patientendokumentation* mit ärztlicher Verordnung
- alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel
- keimarme medizinische Einmalhandschuhe
- ➝*Atemtrainer* (z.B. SMI-Atemtrainer, PEP-Gerät)
- frisches Mundstück, wenn Patient Gerät zum ersten Mal benutzt
- evtl. Abwurfbehälter bzw. klinischer Müllbeutel

Durchführung

- ➝*Patientendokumentation* mit ärztlicher Verordnung prüfen und Hände nach ➝*Hygieneplan* desinfizieren.
- Patienten über geplante Maßnahme informieren

(auch bewusstlose Patienten!) und Zeitpunkt der Durchführung, wenn möglich, mit ihm abstimmen. Anwesenheitslicht einschalten, Fenster und Türen schließen und auf angenehme Raumtemperatur achten.

- Wenn möglich, Mitpatienten und Besucher bitten, das Zimmer zu verlassen oder für Sichtschutz sorgen, Intimsphäre des Patienten beachten.
- Benötigte Gegenstände auf wischdesinfizierter Arbeitsfläche (z.B. Nachttischablage) richten und Atemtrainer auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
- ➞*Patientenbett* auf eine rückenschonende Arbeitshöhe (Beckenhöhe) bringen.
- Patienten unterstützen, Oberkörper hochzulagern, sofern keine Kontraindikation vorliegt.
- Keimarme medizinische Einmalhandschuhe anziehen.
- Patient soll mit seinem Mund das Mundstück fest umschließen.
- **SMI-Atemtrainer:** Ball der ersten oder zweiten Kammer durch eine tiefe Einatmung nach oben bewegen (Abb. 60.2a) und kurz oben halten.
- **PEP-Gerät:** Luft durch das Gerät ausatmen (Abb. 60.2b). Eine Kugel im Inneren sorgt für unterschiedliche Widerstände, wodurch die Ausatemluft in den Bronchien eine Sekretmobilisation bewirkt.
- Jedes Training sollte ca. 10min dauern, wobei der

Patient kurze Pausen einlegen sollte. Führt der Patient die Übungen zu schnell durch, dann besteht die Gefahr der ➞*Hyperventilation* . Der Patient kann das Atemtraining selbstständig mehrmals am Tag durchführen. Achten Sie gerade zu Beginn auf eine korrekte Durchführung.

- Patienten evtl. beim Rücklagern bzw. Anziehen unterstützen und ➞*Patientenbett* wieder auf eine für ihn sichere Höhe bringen (➞*Sturzprophylaxe*).





Abb. 60.2 Atemtraining.

a Inspiratorischer Atemtrainer (SMI-Atemtrainer), hier TRI-Ball.

(Quelle: © A. Fischer/Thieme)

b Exspiratorischer Atemtrainer (PEP), hier Flow-Ball.

(Quelle: © A. Fischer/Thieme)

Praxis

Ein sehr einfacher Atemtrainer, der ohne großen Kostenaufwand eingesetzt werden kann, ist die sog. Blubberflasche. Der Patient bläst über einen Plastikschlauch in eine halb gefüllte Wasserflasche. Dadurch erhöht sich der Ausatemwiderstand und die Lunge entfaltet sich.

Nachbereitung

- Überprüfen, ob Rufanlage bzw. Multimedia-Terminal mit z.B. Telefon, Fernseher und Internet in Reichweite sind.
- Vor dem Verlassen des Zimmers den Patienten nach dem Befinden und seinen Bedürfnissen bezüglich Lagerung, Getränken, Belüftung des Zimmers usw. fragen.
- Gebrauchte Materialien sachgerecht ver- bzw. entsorgen (z.B. Mundstück und Schlauchsystem desinfizieren).
- Abschließend Hände nach ➞*Hygieneplan* desinfizieren.
- Maßnahme durch Eintragung in die ➞*Patientendokumentation* mit Handzeichen und Uhrzeit dokumentieren.

Blick zurück

Hat der Patient ausreichend lange trainiert? Führt der Patient die Übung korrekt aus?

Zusatzinfo

Sekretmobilisation durch Vibration

Vibrationen sind eine zusätzliche Möglichkeit zur Sekretlösung. Dazu eignen sich für Säuglinge und Kleinkinder sehr gut elektrische Zahnbürsten:

- Borsten mit einem Mulltupfer umwickeln,
- in verschiedenen Lagen (Abb. 60.3) immer in Richtung der ➞*Hauptbronchien* von z. B. außen nach innen und unten nach oben vibrieren (dabei nicht zu fest aufdrücken).
- Vibrationen mehrmals täglich durchführen.

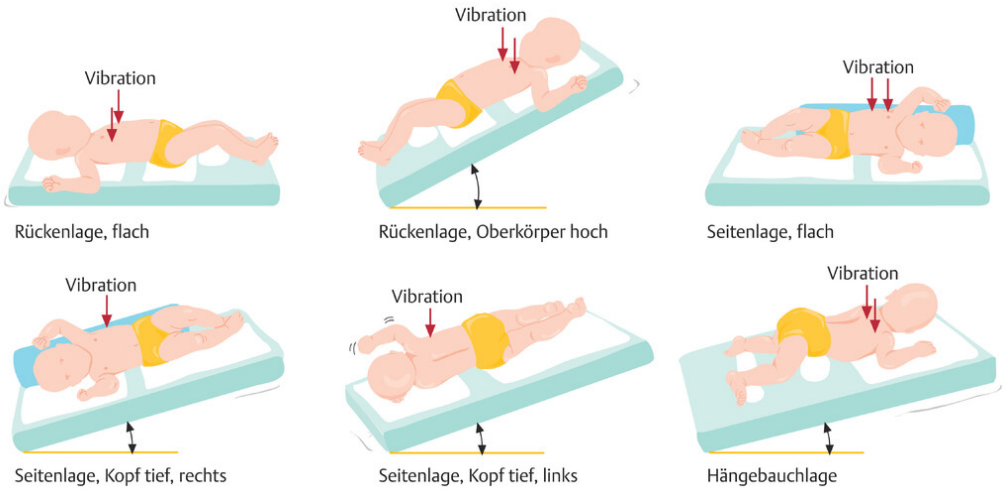


Abb. 60.3 Lagen, in denen Vibration bei Säuglingen und Kleinkindern angewandt werden kann.

(Quelle: Hoehl M. Lagerungsdrainagen. In: Hoehl M, Kullick P, Hrsg. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 5., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2019)

Weiterführende Informationen

- I care – Pflege. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020. DOI: 10.1055/b-006–163255
- Hoehl M, Kullick P, Hrsg. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 5., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2019. DOI: 10.1055/b-006–163248
- Kamphausen U. Prophylaxen in der Pflege. 11., erweiterte und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer; 2023
- Oczenski W, Hrsg. Atmen – Atemhilfen. 11., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2023. DOI: 10.1055/b000000496
- Andreae S, Anton W, Schön J, von Hayek D, Hrsg. I care – Altenpflege Langzeitpflege. 1. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2023. DOI: 10.1055/b000000061
- Deutsche Atemwegsliga e.V. in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Im Internet: www.atemwegsliga.de; Stand: 17.07.2023
- Pflegewerk. Pflegekurse: Pneumonieprophylaxe. Im Internet: www.pflegewerk.com/pflegekurse; Stand: 31.05.2023

Quelle:

Kirschnick O. Pneumonieprophylaxe, Atelektasenprophylaxe. In: Kirschnick O, Hrsg. Pflegetechniken von A bis Z. 6., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2024. doi:10.1055/f-0015-0003-b000000647

Bibliographischer Download (RIS)

Shortlink: https://icare.thieme.de/11M8Q3CF